

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE FALLOS COGNITIVOS COTIDIANOS (CFQ)

Eje V: Neurocognición y Lapsus Atencionales • Modelo de Vulnerabilidad Cognitiva de Broadbent

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Fallos Cognitivos (CFQ; registrado como CFQ-Fallos).
Nombre Original	Cognitive Failures Questionnaire (CFQ; Broadbent, Cooper, FitzGerald & Parkes, 1982).
Autores Originales	Donald E. Broadbent, Sc.D., FRS, Peter F. Cooper, P. FitzGerald y K. R. Parkes (Oxford University).
Adaptación Hispana	García-Martínez et al. (2008); Carrillo-Mora et al. (2013); validación en España y México.
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Propensión subjetiva a lapsus atencionales, de memoria y visomotores.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme estructurado sobre fallos en tareas rutinarias cotidianas.
Composición de Ítems	25 ítems puntuados en escala Likert de 5 opciones (0 a 4; rango 0 a 100 puntos).
Población y Rango	Adultos y ancianos (18 a 85 años); cribado en población laboral, clínica y comunitaria.
Tiempo de Administración	6 a 10 minutos de cumplimentación autónoma presencial o telemática.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para investigación científica y práctica asistencial sin fines comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL CONSTRUCTO DE FALLO COGNITIVO

El **CFQ** fue diseñado por Donald Broadbent y colaboradores (1982) en la Unidad de Psicología Aplicada de Oxford para cuantificar la susceptibilidad individual a fallos cotidianos de ejecución:

- Fallas en Tareas Rutinarias:** Evalúa errores que ocurren en la ejecución de acciones automatizadas que una persona domina por completo (p. ej., olvidar qué se iba a buscar a una habitación, tirar la cerilla y guardar el envoltorio, no escuchar lo que nos dicen).
- Rasgo Estable de Vulnerabilidad:** Broadbent demostró que la propensión a los fallos cognitivos actúa como una dimensión disposicional de personalidad cognitiva, sumamente estable a lo largo del tiempo ($r > 0.80$).
- Impacto en Salud Laboral y Estrés:** Puntuaciones elevadas correlacionan de forma directa con tasas elevadas de accidentes de tráfico, errores en puestos de trabajo de alta exigencia (controladores, cirujanos) y sobrecarga por distrés psicológico.

3. DIMENSIONES EVALUADAS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (25 ÍTEMS)

Dimensión Factorial	Reactivos	Manifestaciones Cotidianas del Fallo Cognitivo
1. Distracción y Lapsus Atencionales	Ítems 1, 2, 7, 10, 11, 14, 18 (7 ítems)	Pérdida del foco atencional en tareas secuenciales, pasar de largo desvíos de ruta habituales y despistes durante la conversación.
2. Fallos de Memoria Cotidiana	Ítems 3, 5, 8, 12, 16, 21, 23 (7 ítems)	Olvido de nombres de personas conocidas, de citas agendadas, de recados inmediatos y de dónde se han dejado objetos usuales.
3. Deslices Visomotores y Espaciales	Ítems 4, 6, 9, 13, 17, 24 (6 ítems)	Chocar contra personas u objetos, soltar o derramar cosas sin querer y perder el control motor en maniobras automáticas.
4. Lapsus de Comunicación y Nombres	Ítems 15, 19, 20, 22, 25 (5 ítems)	Uso involuntario de palabras equivocadas, fenómeno de la punta de la lengua y dificultad momentánea para expresar ideas fluidas.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO METROLÓGICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones clínicas hispanas (García-Martínez et al., 2008; Carrillo-Mora et al., 2013; $N > 750$) corroboran su invariabilidad:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Global	Alfa de Cronbach = 0.88 - 0.92	Elevada homogeneidad interna en los 25 reactivos de autoinforme.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.82$ (a 6 meses)	Extraordinaria constancia temporal; mide un rasgo cognitivo disposicional.
Validez Concurrente	$r = 0.54$ con BDI-II; 0.58 STAI	Correlación moderada con distrés, rumiación ansiosa y fatiga crónica.
Predicción de Accidentes	Odds Ratio = 2.3 ($p < 0.001$)	Validez predictiva robusta para propensión a accidentes laborales y viales.
Estructura Factorial	CFI = 0.92; RMSEA = 0.048	Confirmación del modelo tetrafactorial de Broadbent en muestras hispanas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Calificación:** Cada uno de los 25 reactivos se valora de 0 a 4 puntos según la frecuencia subjetiva experimentada en los últimos 6 meses: 0 = Nunca, 1 = Muy raras veces, 2 = Ocasionalmente, 3 = Frecuentemente, 4 = Muy frecuentemente.
- **Cálculo de Puntuación Total:** Sumatoria directa de los 25 ítems:

$$\text{Puntuación Total CFQ} = \sum_{i=1}^{25} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 100 puntos})$$

- **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor propensión a fallos cognitivos y lapsus en la vida cotidiana.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Percentil	Interpretación y Significación Clínica (Broadbent)
Muy Baja Frecuencia	0 a 22 puntos	$P < 25$	Excelente control atencional; escasísima propensión a lapsus cotidianos.
Promedio Normativo	23 a 42 puntos	$P = 25$ a 84	Nivel habitual en población general; fallos esporádicos no patológicos.
Riesgo Moderado	43 a 54 puntos	$P = 85$ a 94	Punto de corte de riesgo sobrecarga atencional o estrés psicosocial.
Alta Vulnerabilidad	≥ 55 puntos	$P \geq 95$	Nivel patológico severo desregulación atencional con alto riesgo de accidentes.

PARÁMETROS POBLACIONALES Y PUNTO DE CORTE EN ESPAÑA (MEDIA = 31.8; DE = 11.4):

En la población general sana, la media de puntuación se sitúa en **31.8 puntos (DE = 11.4)**. Una puntuación ≥ 43 puntos (**P85**) indica un incremento significativo de fallos que justifica explorar factores de estrés laboral, privación de sueño o cuadro afectivo comórbido. Puntuaciones ≥ 55 puntos (**P95**) exigen evaluación neurocognitiva integral.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL Y CONSULTA EXTERNA

PROTOCOLO DE DESPISTAJE CON EL CUESTIONARIO CFQ:

- **Paso 1 (Administración en Reconocimientos Laborales o Quejas Subjetivas):** Cumplimentar los 25 ítems del CFQ; obtener la sumatoria total.
- **Paso 2 (Triangulación Diagnóstica):**
 - **CFQ ≤ 42 puntos:** Rendimiento atencional habitual; educar sobre pautas de higiene del sueño y desconexión digital.
 - **CFQ 43 a 54 puntos con alta carga emocional:** Evaluar si el incremento es reactivo a ansiedad o síndrome de desgaste profesional (burnout); aplicar escalas complementarias (STAI, BDI-II).
 - **CFQ ≥ 55 puntos en adultos mayores (≥ 60 años):** Realizar despistaje de Deterioro Cognitivo Leve amnésico o disejecutivo mediante pruebas formales de ejecución objetiva (MoCA, TAVEC).
- **Paso 3 (Intervención Ergonómica y Preventiva):** En entornos laborales de riesgo, reestructurar turnos, incorporar pausas atencionales sistemáticas y listas de chequeo antes de tareas críticas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: SOBRECARGA LABORAL Y ERRORES MÉDICOS

Identificación: Mujer de 36 años, médica especialista en anestesiología, remitida al servicio de prevención de riesgos laborales tras cometer dos despistes con la infusión de medicación en quirófano y referir que "se le cae todo de las manos y olvida conversaciones recién mantenidas".

Evaluación con el Cuestionario de Fallos Cognitivos (CFQ):

• **Puntuación Total CFQ = 58 / 100 puntos (Elevación severa, Percentil 97; más de 2 desviaciones típicas sobre la media).**

- **Desglase Factorial:**
- Distracción y Lapsus Atencionales: 18/28 puntos (fallos constantes en tareas automáticas).
- Deslices Visomotores: 14/24 puntos (dejar caer objetos, tropezar en pasillos).
- Fallos de Memoria: 16/28 puntos; Comunicación: 10/20 puntos.

Exploración Neuropsicológica Formal: Pruebas de laboratorio estructuradas (Stroop, TMT-A/B, WAIS-IV) mostraron velocidad y memoria de trabajo estrictamente conservadas (Percentil 75), descartando daño cerebral orgánico o deterioro neurológico.

Diagnóstico: Síndrome de estrés laboral crónico (burnout) con colapso atencional secundario a privación acumulada de sueño en guardias de 24 horas.

Plan Terapéutico: Ajuste temporal de jornada con exención de guardias nocturnas, restitución de ritmos circadianos y entrenamiento en técnicas de reducción de estrés (mindfulness). A los 4 meses, su CFQ descendió a 32 puntos (rango normal).

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

INFLUENCIA DEL ESTADO DE ÁNIMO:

El CFQ es altamente sensible al estado afectivo; una puntuación alta refleja frecuentemente depresión o ansiedad, no declive neurodegenerativo primario.

SUBESTIMACIÓN EN ANOSOGNOSIA:

Pacientes con disfunción frontal o demencia incipiente pueden puntuar bajo en el CFQ al ignorar sus propios errores cotidianos; triangular con un testigo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Broadbent, D. E., Cooper, P. F., Fitzgerald, P., & Parkes, K. R. (1982). The Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) and its correlates. *British Journal of Clinical Psychology*, 21(1), 1-16.
2. Wallace, J. C., Kass, S. J., & Stanny, C. J. (2002). The Cognitive Failures Questionnaire revisited: Investigating the memory, attention, and motor slips subscales. *The American Journal of Psychology*, 115(3), 415-429.
3. García-Martínez, J., et al. (2008). Adaptación y propiedades psicométricas del Cuestionario de Fallos Cognitivos en población española. *Ansiedad y Estrés*, 14(2), 175-188.
4. Carrillo-Mora, P., et al. (2013). Validación de la versión mexicana del Cuestionario de Fallos Cognitivos en adultos jóvenes. *Salud Mental*, 36(6), 465-472.